2.1.3.3. 입퇴실 절차 – 뇌졸중집중치료실

제 정 일	2008.12.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	신경과, 뇌졸중집중치료실, 중환자실운영위원회				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 2.1.3 중환자실/특수치료실 입실 절차 JCI Standard 7th Edition: ACC.2.3

제1조 (목적)

1. 집중치료가 필요한 급성기 뇌졸중 환자에게 한정된 자원을 효율적으로 활용하여 적절한 의료서비스를 제공하기 위해 표준화된 뇌졸중집중치료실 입퇴실 절차를 준수하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. SU(Stroke Unit): 뇌졸중집중치료실

제3조 (절차)

1. 입실 기준
   1) 뇌졸중 발병 후 7일 이내의 급성기 뇌졸중
   2) 재관류치료를 받은 환자
   3) 뇌경색이 진행하는 환자
   4) 반복되는 일과성 허혈 발작 환자
   5) 뇌헤르니아증이 진행하는 환자
   6) 중재적 치료
   7) 뇌혈관 조영술 CP(Critical Pathway) 환자
      (1) 뇌혈관 조영술 CP(Critical Pathway): 스텐트 삽입 후 1년이 경과한 환자를 대상으로 추적 확인하기 위해 시행하며 검사 후 악화되거나 새롭게 발생한 신경학적 증상이 없는 경우 익일 퇴원한다.

2. 입실 절차
   1) 입실 기준에 따라 주치의(담당교수)가 환자의 입실을 결정한다.
   2) 의료진은 입실 시 환자 및 보호자에게 입실 필요성을 설명하고 동의를 받는다.
   3) 입실 시점의 환자 상태를 평가하고 입실 기준에 부합하는지를 의무기록에 기록한다.

3. 퇴실 기준: 퇴실하는 환자는 급성기를 지나 환자의 신경학적 증세가 안정화된 경우 주치의(담당교수)의 결정에 의해 이루어지며 그 기준은 아래와 같다.
   1) 발병 후 7일 이내의 급성기 뇌졸중 환자 또는 재관류치료를 받은 환자: 24시간 이상 NIHSS(National Institutes of Health Stroke Scale) 점수의 악화가 없는 상태에서 초기 뇌경색 평가가 종료된 경우

2) 뇌경색이 진행하는 환자: 48시간 이상 NIHSS(National Institutes of Health Stroke Scale) 점수의 악화가 없는 경우
3) 반복되는 일과성 허혈 발작 환자: 24시간 이상 발작이 없는 경우
4) 뇌헤르니아증이 진행하는 환자: 뇌헤르니아증의 위험성이 사라졌거나 고삼투성 제재를 최고용량에서 최소한 2단계 이상 감량할 수 있는 경우
5) 중재적 치료 또는 뇌혈관 조영술 CP (Critical Pathway) 환자: 검사나 시술 후 악화되거나 새롭게 발생한 신경학적 증상 없이 12시간이 경과한 경우

4. 퇴실 절차
1) 퇴실 기준에 따라 주치의(담당교수)가 환자의 퇴실을 결정한다.
2) 의료진은 퇴실 시 환자 상태를 평가하고 퇴실 기준에 부합하는지를 의무기록에 기록한다.

5. 타병원에서 전원 요청이 있을 경우 뇌졸중집중치료실 주치의(담당교수)가 환자 상태 및 병상 상황에 맞추어 전원 가능여부 및 전원 시점을 결정한다.

제4조 (부록)

제5조 (참고)
1. 뇌졸중 치료실의 설립과 운영 Korean Journal of Stroke 2006;9: 171-178.
2. 대한뇌졸중학회 뇌졸중진료지침 2-1-2 뇌졸중 전문치료실과 뇌졸중센터

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)
1. 이 내규는 2008년 12월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)
1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)